

LEPL1805 – Gestion des personnes

Centre Médical Horizon

Groupe 6 – Année académique 2025-2026

Plan de la présentation

- Présentation du Centre Médical Horizon
- Méthodologie d'analyse et concepts de gestion des personnes
- Intégration des nouveaux collaborateurs
- Requalification et évolution professionnelle des équipes
- Gestion des situations de crise
- Apprentissages managériaux et conclusion

Centre Médical Horizon

Établissement de santé pluridisciplinaire organisé sur deux sites (urbain et rural) assurant des soins 24h/24 et 7j/7.

- Statut : ASBL – mission de service public de santé
- Capacité : 600 lits (500 urbain & 100 rural)
- Activités : soins hospitaliers, urgences, stérilisation, nettoyage, prévention des infections
- Organisation : CEO, directions médicales, soins infirmiers, opérations, finances, SI
- Concertation sociale : CE, CPPT, délégation syndicale (DS)

Valeurs & indicateurs clés

- Excellence des soins et approche centrée sur le patient
- Solidarité, apprentissage collectif, respect et dialogue social
- Formation continue & rituels : journées de premiers secours, Arbre de Mémoire

Indicateurs de performance suivis :

- Taux de réadmission et durée moyenne de séjour
- Délai moyen de prise en charge aux urgences
- Coût moyen par patient
- Nombre moyen d'opérations mensuelles

Méthodologie & concepts

L'analyse suit une démarche en trois étapes pour chaque concept de gestion des personnes :

- Analyse théorique (Rousseau, Argyris, Deci & Ryan, Adler & Borys, Prosci, Coombs, Perrow, etc.)
- Application au Centre Médical Horizon (cas fictif SmartHygiene)
- Étude de terrain & synthèse des apprentissages managériaux

Trois concepts centraux : intégration des nouveaux collaborateurs, requalification & évolution professionnelle, gestion des crises.

Intégration des nouveaux collaborateurs

L'intégration (onboarding) regroupe les pratiques qui accompagnent l'arrivée d'un nouveau collaborateur et facilitent son adaptation.

- Clarifier le rôle attendu et les règles formelles / informelles
- Transmettre la culture organisationnelle et les valeurs
- Réduire le stress lié à l'entrée dans l'organisation
- Renforcer engagement, motivation, performance et cohésion d'équipe

Intégration – cadres théoriques

- Contrat psychologique (Rousseau) : attentes réciproques implicites / explicites entre individu et organisation.
- Théories « espousées » vs « en usage » (Argyris) : cohérence entre discours et pratiques managériales.
- Théorie de l'autodétermination (Deci & Ryan) : répondre aux besoins d'autonomie, compétence, appartenance.
- Développement des équipes (Tuckman) : arrivée d'un nouveau peut réactiver tensions et nécessiter un pilotage fin.

Intégration – CMH & terrain

- Enjeu majeur : deux sites, travail en 3 services, forte pression opérationnelle.
- Mix de formations techniques, rituels institutionnels et politique de formation continue.

Étude de terrain – Cliniques de l'Europe :

- Séances d'accueil RH, programme structuré d'intégration et suivis mensuels.
- ICANes pour l'accompagnement spécifique des infirmiers, binômes et observation sur le terrain.

Intégration – apprentissages

- L'intégration est un processus continu, pas un événement unique.
- Rôle central du manager : communication, écoute, cohérence discours / pratiques.
- Lien direct avec engagement, bien-être et performance à long terme.
- Importance de la clarification des rôles et de la qualité de la relation de travail.

Requalification & évolution professionnelle

Ensemble des processus par lesquels les collaborateurs adaptent, développent ou transforment leurs compétences dans un contexte de changement.

- Réponse aux transformations technologiques et organisationnelles (automatisation, numérisation).
- Maintien de l'employabilité et de la motivation des équipes.
- Articulation entre performance organisationnelle et reconnaissance individuelle.

Requalification – cadres théoriques

- Adler & Borys : l'automatisation peut conduire à une requalification qualitative (plus d'abstraction et de responsabilité).
- Ambivalence du changement : opportunité d'apprentissage mais aussi source de stress si mal accompagnée.

Modèle ADKAR (Prosci) :

- Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement – cinq dimensions pour réussir la transition.

Requalification – CMH & exemples

- Automatisation du nettoyage et de la stérilisation avec nouvelles machines (UV).
- Inquiétudes fortes : rumeurs, menace de grève, risques de départ de cadres.
- Choix managérial : requalifier plutôt que supprimer des postes, former à la supervision des machines.
- Création d'un comité de concertation (direction, cadres, syndicats) pour rétablir la confiance.

Exemples externes : Siemens et Volvo – requalification concertée vers des métiers plus qualifiés (industrie 4.0, mobilité électrique).

Requalification – apprentissages

- La requalification doit être pensée comme une opportunité, pas comme une contrainte imposée.
- Importance du dialogue social, de la transparence et de la reconnaissance des inquiétudes.
- Rôle du manager comme médiateur entre objectifs stratégiques et attentes individuelles.
- Suivi par indicateurs : infections, coûts, délais, qualité du travail et climat social.

Gestion des situations de crise

Ensemble des dispositifs et pratiques pour faire face à un événement grave, imprévu et perturbateur.

- Forte incertitude, pression temporelle, enjeux humains élevés.
- Objectifs : protéger les parties prenantes, limiter les dommages, restaurer un fonctionnement stable.
- Dimension profondément humaine : coopération, décision sous stress, maintien du sens collectif.

Gestion des crises – cadres théoriques

- Coombs : théorie des attributions – perception de la responsabilité influence les attentes de communication.
- Perrow : accidents normaux – inévitabilité des incidents dans les systèmes complexes.
- Weick & Sutcliffe : organisations à haute fiabilité – vigilance, détection des signaux faibles.
- Fink : cinq phases de la crise – importance de l'anticipation et de l'apprentissage post-crise.
- Leadership de crise : production de sens, régulation des émotions, préservation de la confiance.

Crises – CMH & organisation

- Cellule de crise : direction, équipes médical/infirmiers, IT, communication, syndicats.
- Types de crises : techniques (panne IT), sanitaires (épidémie), sociales (grève).
- Protocoles, chaîne décisionnelle, communication interne rapide, soutien psychologique.
- Simulations et audits post-crise pour renforcer la résilience organisationnelle.

Cas Tylenol : communication transparente, retrait de produits, innovation (emballage) comme réponse exemplaire.

Crises – terrain & apprentissages

Clinique Al Madina (Casablanca) :

- Protocoles pour crises sanitaires, organisationnelles et humaines.
- Chaîne de décision claire, communication interne rapide, soutien psychologique.
- Analyse rétrospective systématique après chaque crise pour améliorer les dispositifs.

Apprentissage clé : la gestion de crise révèle la solidité des pratiques de gestion des personnes et du climat de confiance.

Conclusion & apports pour notre pratique

La performance durable du Centre Médical Horizon repose sur l'articulation entre décisions technologiques et gestion humaine des ressources.

- Intégration, requalification et gestion des crises sont trois leviers complémentaires de GRH.
- Le management efficace exige cohérence, reconnaissance et prise en compte des dynamiques humaines.
- Les concepts vus au cours fournissent un cadre pour agir de façon réfléchie dans des organisations complexes.

Merci pour votre attention

Questions & discussion